Historia clínica, diagnóstico y planificación en implantología

12 apartados **40** min de lectura **30** preguntas argumentadas

En implantología casi todos los problemas graves nacen antes de la cirugía: un paciente que no debía operarse, una medicación sin contrastar, unas expectativas imposibles o un plan que empezó por el hueso en vez de por la prótesis. La historia clínica es la herramienta que evita esos errores y, además, el documento que te defiende si algo sale mal. Este tema te enseña a usarla para decidir si puedes operar, qué tiene el paciente y qué vas a hacer.

Antes de empezar

- La **historia clínica** es el registro ordenado de todo lo que sabes y haces con un paciente. Es a la vez una herramienta para decidir y una prueba legal.
- La **anamnesis** es la parte que obtienes hablando con él; la **exploración** es lo que ves y tocas tú.
- Un **implante** es un tornillo (normalmente de titanio) que sustituye a la raíz de un diente y sobre el que se fija una **prótesis**, que es el diente o los dientes artificiales.

Al terminar sabrás

- ✓ Ordenar la planificación desde la prótesis hacia el implante y justificar cada paso.
- ✓ Redactar un consentimiento válido.
- ✓ Prescribir la profilaxis según la evidencia vigente.

✓ Decidir con criterio si tratar o derivar a un paciente.

---

1 La hoja de ruta: tres preguntas y cinco bloques

1 pregunta del test

Imagínalo así

Piensa en un viaje en coche de Madrid a Roma. Antes de arrancar necesitas saber **adónde vas**, si tienes **gasolina** para llegar y si dispones de un **mapa**. Salir sin nada de eso es improvisar. En implantología pasa igual: antes de tocar al paciente debes saber qué tiene, si puedes operarlo y qué le vas a hacer.

La clase organiza todo el tema alrededor de **tres preguntas** que la historia clínica debe permitirte contestar:

- **¿Puedo operar a este paciente?** (y en qué condiciones). Se responde con la valoración médica.
- **¿Qué tiene?** Se responde con la valoración diagnóstica: qué exploro y con qué.
- **¿Qué le voy a hacer?** Se responde con el plan de tratamiento, que se construye **desde la prótesis hacia el implante**.

Esas tres preguntas se desarrollan en **cinco bloques**: (1) la historia clínica como documento asistencial y legal; (2) la anamnesis y la medicación, que deciden si se opera; (3) la exploración y las pruebas de imagen; (4) el plan de tratamiento, que parte de la prótesis; y (5) lo que se necesita antes de operar: consentimiento informado, fármacos y control de complicaciones.

> **Anamnesis**
> Es la parte de la historia clínica que se obtiene hablando con el paciente: por qué viene, qué enfermedades y alergias tiene, qué medicación toma, qué hábitos tiene. Todavía no es la exploración: aquí solo se pregunta y se escucha.

Así cae en el test

El profesor avisó de qué se evalúa: casos con anamnesis e imágenes en los que hay que **decidir si tratar o derivar**, indicar qué exploración harías, qué hallazgos esperas y **en qué orden planificas**. **No** se evalúa memorizar clasificaciones, pero sí **justificar** cada decisión. Cuando estudies, pregúntate siempre «¿qué haría y por qué?».

Idea clave

Primero el paciente, luego el diagnóstico, y el plan siempre desde la prótesis hacia el implante. Nunca al revés.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 ¿Cuáles son las tres preguntas que debe permitir responder la historia clínica antes de actuar?

A ¿Cuánto cuesta el tratamiento?, ¿cuántos implantes caben? y ¿cuándo se cobra?

B ¿Puedo operar a este paciente?, ¿qué tiene? y ¿qué le voy a hacer?

C ¿Qué marca de implante uso?, ¿qué anestesia pongo? y ¿qué radiografía pido?

D ¿Quién me envía al paciente?, ¿qué seguro tiene? y ¿cuándo vuelve?

Respuesta correcta: **B**

La clase presentó una hoja de ruta de tres preguntas: si se puede operar al paciente, qué tiene y qué se le va a hacer. Cada una se contesta con una parte de la historia: valoración médica, valoración diagnóstica y plan de tratamiento.

A **¿Cuánto cuesta el tratamiento?, ¿cuántos implantes caben? y ¿cuándo se cobra?** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son cuestiones económicas y técnicas, no las preguntas que ordenan la historia clínica.

B **¿Puedo operar a este paciente?, ¿qué tiene? y ¿qué le voy a hacer?** ✓ Correcta
Correcta. Son las tres preguntas que ordenan todo el tema: valoración médica, diagnóstico y plan de tratamiento.

C **¿Qué marca de implante uso?, ¿qué anestesia pongo? y ¿qué radiografía pido?** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son decisiones concretas que vienen después de responder a las tres preguntas básicas.

D **¿Quién me envía al paciente?, ¿qué seguro tiene? y ¿cuándo vuelve?** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son datos administrativos, no las preguntas clínicas que guían la historia.

2 La historia clínica: documento asistencial y legal

3 preguntas del test

La historia clínica es el registro **completo y sistemático** de los datos de salud de una persona: antecedentes, exploraciones, pruebas,

diagnósticos, tratamientos y evolución. Idealmente se ordena cronológicamente. No es un trámite administrativo: es la base sobre la que se toman todas las decisiones del caso. Si la base falla, el resto también.

Debe ser **rigurosa y legible** y contener todo lo que justifique el diagnóstico y el tratamiento. Piensa que, si hay una reclamación, con ese documento tendrás que demostrar por qué llegaste a ese diagnóstico y por qué indicaste ese tratamiento. Por eso deben constar también las **alternativas** que se ofrecieron al paciente, incluida la de **no hacer nada**, con sus consecuencias.

> **Ley 41/2002**
> Ley que regula la **autonomía del paciente** y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Sustituyó al modelo paternalista (el profesional decidía lo mejor «como un padre») por otro en el que el paciente es un adulto que decide, y por tanto es **responsable de sus decisiones**.

Ejemplo

Si el paciente elige no tratarse y esa alternativa consta en la historia, cuando vuelva meses después quejándose se podrá demostrar que se le ofreció, se le explicaron las consecuencias y decidió él. Lo mismo ocurre si ofreces una prótesis removible y una fija y elige la removible: la historia prueba que eligió con información.

Reglas prácticas que se destacaron

- **Confidencialidad**: es un documento sometido a la ley de protección de datos, muy exigente en sanidad. El centro es responsable de su custodia.
- **Acceso del paciente**: tiene derecho a una copia de los **datos objetivos y clínicos**, pero no de tus anotaciones o impresiones personales. Nunca se entrega el **original**, que permanece en el centro. Se entrega un documento fiel, no necesariamente una fotocopia.
- **Cuidado con lo que escribes**: no pongas valoraciones personales ni insultos sobre el paciente.
- **Conservación**: mínimo **5 años** desde el alta de cada proceso (la normativa autonómica puede variar).

- **Lo que no está escrito, no se hizo.** Registra cada visita y todo lo que hables con el paciente (por ejemplo, que debe dejar de fumar o mejorar su higiene), incluidos los lotes de los cartuchos de anestesia.
- **Fecha, firma e identificación** de quien escribe cada nota.

> **Lex artis**
> Conjunto de prácticas que la profesión considera correctas en cada momento. Lo que «es lex artis» (por ejemplo, el consentimiento por escrito en cirugía) se hace siempre así, aunque nadie lo exija en cada caso.

Funciones de la historia clínica

Función	Para qué sirve
Asistencial	Decidir y registrar el tratamiento.
Docente	Material para enseñar, sobre todo en hospital.
Científico-investigadora	Estudios, por ejemplo epidemiológicos (cuántos implantes fracasan).
Administrativa	Comprobar qué se hizo y facturarlo.
Legal	Prueba de lo que se hizo y de lo que se informó.

> **Así cae en el test**
> La clase insistió en dos ideas: (1) la historia es el documento asistencial **y legal** del caso, y (2) **lo que se informa importa casi tanto como lo que se hace**. Aparecen tanto en las preguntas de este tema como en cualquier caso práctico.

> **Idea clave**
> Ley 41/2002: autonomía del paciente e información documentada. Conservación mínima de 5 años. Al paciente se le da copia de los datos clínicos, nunca el original ni tus anotaciones personales.

Pon a prueba este apartado 3
Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

2 **Según la Ley 41/2002, ¿qué implica que el paciente decida entre las alternativas que se le ofrecen, incluida no tratarse?**

A Que el profesional queda exento de informar de las alternativas.

B Que la decisión final corresponde al odontólogo, que conoce mejor el caso.

C Que solo se pueden ofrecer alternativas que el profesional recomiende.

D Que es responsable de su decisión, por lo que conviene registrar las alternativas ofrecidas y su elección.

Respuesta correcta: **D**

La Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y las obligaciones de información y documentación. Frente al antiguo modelo paternalista, el paciente decide y por eso responde de lo que decide. La historia debe dejar constancia de las alternativas, incluida no hacer nada.

A **Que el profesional queda exento de informar de las alternativas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La ley exige informar; la autonomía depende de que la decisión sea informada.

B **Que la decisión final corresponde al odontólogo, que conoce mejor el caso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso describe el modelo paternalista, superado por la autonomía del paciente.

C **Que solo se pueden ofrecer alternativas que el profesional recomiende.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Deben ofrecerse las alternativas razonables, incluida la de no tratar, aunque no se recomiende.

D **Que es responsable de su decisión, por lo que conviene registrar las alternativas ofrecidas y su elección.** ✓ Correcta
Correcta. La autonomía del paciente conlleva responsabilidad sobre sus decisiones y la historia debe probar que se informó.

3 ¿Durante cuánto tiempo mínimo debe conservarse la historia clínica desde el alta de cada proceso, según lo explicado en clase?

A 5 años

B 1 año

C 2 años

D 3 años

Respuesta correcta: **A**

En clase se dio una conservación mínima de 5 años desde el alta de cada proceso, matizando que la normativa autonómica puede cambiar ese plazo. Además se recordó que lo que no está escrito no consta.

A **5 años** ✓ Correcta
Correcta. Es la conservación mínima indicada, aunque la normativa autonómica puede variar.

B **1 año** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un plazo demasiado corto respecto al mínimo indicado.

C **2 años** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Queda por debajo del mínimo de conservación explicado.

D **3 años** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tampoco alcanza el mínimo de 5 años desde el alta.

Para revisar: El profesor advirtió que cada normativa autonómica puede cambiar el plazo; la pregunta se basa en el mínimo general de 5 años.

4 Un paciente solicita una copia de su historia clínica. ¿Qué procede?

A Fotocopiarle la historia completa, incluidas las anotaciones personales.

B Entregarle el original para que lo guarde él.

C Entregarle un documento fiel con sus datos objetivos y clínicos, sin tus anotaciones personales y sin dar el original.

D Negarse, porque la historia pertenece solo al centro.

Respuesta correcta: **C**

El paciente tiene derecho de acceso y a copia de los datos objetivos y clínicos, pero no de las anotaciones personales. Nunca se entrega el original, que el centro custodia con confidencialidad.

A **Fotocopiarle la historia completa, incluidas las anotaciones personales.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las anotaciones o impresiones personales del profesional no se transmiten al paciente.

B **Entregarle el original para que lo guarde él.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El original debe permanecer siempre en el centro, que es responsable de su custodia.

C **Entregarle un documento fiel con sus datos objetivos y clínicos, sin tus anotaciones personales y sin dar el original.** ✓ Correcta
Correcta. Tiene derecho a los datos clínicos, pero no a las impresiones personales, y el original queda en el centro.

D **Negarse, porque la historia pertenece solo al centro.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El paciente tiene derecho de acceso y a una copia de sus datos clínicos.

3 La primera visita: motivo de consulta y expectativas

3 preguntas del test

El paciente entra y se empieza con una pregunta **abierta**, del estilo «¿en qué puedo ayudarle?». La intención es que cuente libremente, con sus palabras y sin que lo induzcas, lo que le pasa. Déjale hablar sin

interrumpir al principio; si se alarga, hay que cortar con tacto y reconducir porque el tiempo de consulta es limitado.

Cómo ordenar la entrevista

1. Pregunta abierta y escucha inicial sin interrumpir.
2. Anota el **motivo de consulta** entre comillas, en palabras del paciente.
3. Ordena tú la cronología («primero fue esto, ¿lo he entendido bien?») repitiendo sus palabras.
4. Pregunta por **tratamientos previos**: qué ha probado, qué funcionó y qué no.
5. Pregunta sin rodeos **qué espera conseguir, en cuánto tiempo y con qué presupuesto**.
6. Registra por escrito todo lo hablado, sobre todo las alternativas y lo que el paciente aceptó.

> **Expectativa realista**
> La que coincide con lo que el caso permite conseguir. En implantología, la **distancia entre lo que el paciente espera y lo que es posible** explica más reclamaciones que las complicaciones quirúrgicas. Los problemas suelen ser malentendidos, no malas técnicas.

Imagínalo así

Pedir dientes perfectos, hoy mismo y baratos es como ir a la carnicería y pedir «el mejor jamón, dos kilos, y que sea barato»: o se renuncia a algo o no existe. Si no lo dices tú claramente, lo asumirá el paciente como una promesa.

Ejemplo

Una paciente con un incisivo con recesión, defecto óseo, movilidad y supuración, fumadora, hipertensa y con mala higiene, pedía quitarlo, poner implante inmediato con carga inmediata y un resultado estético perfecto. El pronóstico era malo y sus expectativas irreales. La respuesta correcta fue explicarle un plan por fases (infección, hueso, encía, implante) y, al no aceptar, **no tratarla**. Una vez que empiezas el tratamiento no puedes desentenderte; rechazar el caso es posible **solo en la primera visita**.

Buenas prácticas

- Muestra **casos comparables** al suyo (sector anterior con sector anterior), no tus mejores casos.
- Informa de todo lo necesario y deja constancia, incluso de lo que desaconsejas.
- El plan de tratamiento firmado por el paciente no significa que lo acepte: prueba que se le **informó**.
- Una expectativa no protegida en la primera visita se convierte en un problema en las siguientes.

Cinco errores frecuentes al abrir una historia

- Copiar análisis o datos anteriores sin actualizarlos.
- No preguntar por **suplementos, fitoterapia y productos sin receta**, que pueden alterar la vida media de los fármacos que usamos.
- Dar por buena la lista de medicación que recuerda el paciente **sin contrastarla**.
- No registrar lo explicado ni las alternativas ofrecidas.
- No fechar, no firmar ni identificar al profesional que escribe la nota.

Así cae en el test

Casos típicos: dos pacientes con radiografías casi iguales pero distinto resultado esperable porque cambian la medicación, el biotipo gingival (fino o grueso) y las expectativas. Para decidir si tratas o rechazas, justifica con esos tres factores.

Idea clave

Pregunta abierta, motivo entre comillas, expectativas identificadas desde el primer día y todo por escrito. Si lo que pide es imposible, se rechaza en la primera visita.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

5 ¿Cómo conviene iniciar la entrevista con un paciente nuevo?

A Con una batería de preguntas cerradas sobre enfermedades.

B Con una pregunta abierta, dejándole contar libremente el motivo con sus palabras y sin interrumpirle al principio.

C Mirando primero su radiografía o su escáner.

D Proponiéndole directamente el tratamiento que se le va a realizar.

Respuesta correcta: **B**

La entrevista empieza con una pregunta genérica que invita a hablar sin inducir. Se anota el motivo entre comillas y después se ordena la cronología con el paciente, repitiendo sus palabras.

A **Con una batería de preguntas cerradas sobre enfermedades.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Se empieza de forma abierta; la anamnesis estructurada viene después.

B **Con una pregunta abierta, dejándole contar libremente el motivo con sus palabras y sin interrumpirle al principio.** ✓ Correcta

Correcta. Así se recoge el motivo de consulta sin inducirlo y se ordena la cronología después.

C **Mirando primero su radiografía o su escáner.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Se trata al paciente y no la imagen; la radiografía va después de explorarlo.

D **Proponiéndole directamente el tratamiento que se le va a realizar.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Antes hay que conocer el motivo, las expectativas y el estado general.

6 **En implantología, ¿qué explica más reclamaciones y cuándo debe abordarse?**

A La distancia entre lo que el paciente espera y lo que es posible; debe identificarse en la primera visita.

B Las complicaciones quirúrgicas; se abordan al terminar el tratamiento.

C El coste del material; se aborda al presentar el presupuesto final.

D La falta de higiene del paciente; se aborda cuando aparecen los problemas.

Respuesta correcta: **A**

El profesor explicó que la brecha entre expectativas y realidad genera más reclamaciones que las complicaciones. Por eso se identifica en la primera visita: una vez iniciado el tratamiento ya no puedes desentenderte, y se recomienda rechazar los casos con expectativas imposibles.

A **La distancia entre lo que el paciente espera y lo que es posible; debe identificarse en la primera visita.** ✓ Correcta
Correcta. Los malentendidos sobre expectativas generan más reclamaciones que las complicaciones, y deben detectarse al empezar.

B **Las complicaciones quirúrgicas; se abordan al terminar el tratamiento.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En clase se indicó que las expectativas explican más reclamaciones, y deben tratarse antes de empezar.

C **El coste del material; se aborda al presentar el presupuesto final.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la causa principal señalada ni se deja para el final.

D **La falta de higiene del paciente; se aborda cuando aparecen los problemas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un factor de riesgo, no la principal causa de reclamación señalada.

9 ¿Cuál es un error frecuente al abrir una historia clínica?

A Fechar y firmar cada nota con el profesional que la escribe.

B Dar por buena la lista de medicación que recuerda el paciente sin contrastarla.

C Registrar las alternativas ofrecidas y lo explicado al paciente.

D Preguntar por aparatos y sistemas aunque el paciente diga que está sano.

Respuesta correcta: **B**

Entre los cinco errores citados están copiar análisis sin actualizar, no preguntar por suplementos y fitoterapia, no contrastar la medicación que el paciente recuerda, no registrar lo explicado y no fechar ni firmar.

A **Fechar y firmar cada nota con el profesional que la escribe.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una buena práctica, no un error; el error es no hacerlo.

B **Dar por buena la lista de medicación que recuerda el paciente sin contrastarla.** ✓ Correcta
Correcta. Es uno de los errores señalados, junto con no preguntar por suplementos o fitoterapia.

C **Registrar las alternativas ofrecidas y lo explicado al paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo correcto; el error es no registrarlo.

D **Preguntar por aparatos y sistemas aunque el paciente diga que está sano.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es la actitud correcta, porque «estoy sano» no es una respuesta válida.

4 Anamnesis estructurada: filiación, antecedentes y hábitos

2 preguntas del test

Una vez que el paciente te ha contado libremente por qué viene, empiezas a recoger datos de forma **estructurada**. Estos son los apartados básicos:

- **Filiación**: nombre, edad, sexo, profesión (recomendable) y contacto del médico de cabecera. La edad y la profesión no son burocracia:

condicionan expectativas y riesgos.

- **Enfermedad actual**: todo lo que el paciente trae a consulta, con su cronología (cuándo empezó, cómo evolucionó, qué se le ha hecho).
- **Antecedentes hereditarios**: por ejemplo, predisposición familiar a enfermedad periodontal.
- **Antecedentes personales**: enfermedades, intervenciones, hospitalizaciones, tabaquismo y **alergias** (a medicamentos, metales, látex y anestésicos).

> **Imagínalo así**
>
> «Estoy sano» no es una respuesta válida, igual que decir «mi coche va bien» porque nunca lo has llevado al taller. Muchos pacientes «sanos» no van al médico y, al monitorizarlos, se descubren arritmias o saturaciones bajas. Hay que **preguntar por aparatos y sistemas**.

Alergias: no basta con anotar «alérgico a la penicilina». Pregunta **qué ocurrió exactamente**, cuándo y si se confirmó con pruebas, porque muchos pacientes que se creen alérgicos no lo son (a menudo fue una reacción por la propia infección o por un preparado antiguo).

Lo que más cambia el plan de tratamiento

- Diabetes mal controlada.
- Osteoporosis en tratamiento, sobre todo si es con fármacos intravenosos.
- **Radioterapia** de cabeza y cuello.
- Inmunodepresión o toma de inmunomoduladores.

> **Hábitos que se registran**
>
> **Tabaco**: es el factor de riesgo **modificable** más importante en implantología porque afecta a la osteointegración, a la cicatrización de tejidos blandos y se relaciona directamente con la periimplantitis. Hay que **cuantificarlo** (cigarrillos al día y años de consumo; «fumo poco» no es un dato). Además: alcohol, higiene oral, bruxismo, desgaste, rotura de prótesis, dieta y sedentarismo.

Ejemplo

Con un paciente de higiene deficiente no se le acusa: se le dice que «no estamos consiguiendo los objetivos» y se le propone una sesión con la higienista para enseñarle técnicas. Todo eso se escribe y se presupuesta. Si más adelante pierde implantes, la historia demuestra que se le advirtió y se le ofreció ayuda.

Así cae en el test

Pregunta clásica: ¿qué factor de riesgo modificable es el más importante? **El tabaco**, y debe registrarse de forma cuantificada. Otra: ¿qué hay que preguntar ante una alergia referida? Qué ocurrió realmente.

Idea clave

Filiación y médico de cabecera; enfermedad actual cronológica; alergias detalladas; hábitos cuantificados. Preguntar por sistemas aunque diga que está sano.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

7 **Un paciente dice ser alérgico a la penicilina. ¿Qué conviene hacer en la anamnesis?**

A Anotarlo y evitar cualquier antibiótico sin más.

B Ignorarlo si la reacción fue en la infancia.

C Descartarlo, porque casi siempre se equivocan.

D Preguntar qué ocurrió exactamente y cuándo, y valorar pruebas alérgicas, porque a menudo no es una alergia verdadera.

Respuesta correcta: **D**

En clase se insistió en preguntar qué pasó exactamente, no solo si el paciente es alérgico. Muchos que se declaran alérgicos a la penicilina no lo son tras hacerles pruebas, por lo que conviene aclararlo.

A **Anotarlo y evitar cualquier antibiótico sin más.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hay que investigar la reacción, no limitarse a anotar la etiqueta.

B **Ignorarlo si la reacción fue en la infancia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se ignora; se pregunta qué ocurrió y se valora confirmarla.

C **Descartarlo, porque casi siempre se equivocan.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se descarta sin comprobarlo; puede ser real.

D **Preguntar qué ocurrió exactamente y cuándo, y valorar pruebas alérgicas, porque a menudo no es una alergia verdadera.** ✓ Correcta
Correcta. Muchos pacientes que se creen alérgicos no lo son, y conviene confirmarlo.

8 ¿Cuál es el factor de riesgo modificable más importante en implantología y cómo debe registrarse?

A El alcohol, anotando «consumo moderado».

B El bruxismo, anotando solo si hay desgaste.

C El tabaco, cuantificado en cigarrillos al día y años de consumo.

D La higiene oral, anotando «regular».

Respuesta correcta: **C**

El tabaco es el factor de riesgo modificable más importante: afecta a la osteointegración, a la cicatrización de tejidos blandos y se asocia a la periimplantitis. Debe cuantificarse porque «fumo poco» no es un dato.

A **El alcohol, anotando «consumo moderado».** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se registra, pero no es el factor modificable más importante.

B **El bruxismo, anotando solo si hay desgaste.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un factor relevante, pero no el más importante modificable.

C **El tabaco, cuantificado en cigarrillos al día y años de consumo.** ✓ Correcta
Correcta. Afecta a la osteointegración, a la cicatrización y a la periimplantitis, y debe cuantificarse.

D **La higiene oral, anotando «regular».** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Importa, pero el tabaco es el factor señalado como más importante.

5 Medicación y enfermedades que cambian la cirugía

4 preguntas del test

La anamnesis y la medicación **deciden si se opera**. No basta con saber qué toma el paciente: hay que saber **por qué** lo toma.

Medicación o enfermedad	Qué hay que hacer o saber
Anticoagulantes y antiagregantes	Rara vez se suspenden. Se planifica **hemostasia local** y se consulta al médico antes de modificar nada. Pregunta siempre el **motivo**.
Antirresortivos (osteoporosis)	Averigua **vía, dosis y duración**, por el riesgo de osteonecrosis, y sigue el protocolo correspondiente.
Corticoides e inmunosupresores	Cicatrización más lenta y mayor riesgo de infección.
Antidiabéticos / diabetes	Lo que importa es el **control metabólico**, no el fármaco: se valora con la **hemoglobina glicosilada**.

Ejemplo

Un paciente anticoagulado puede decir «tengo una válvula cardíaca»: eso implica **profilaxis antibiótica**, algo que puede ser vital. Otro puede haber sufrido un infarto hace dos meses y estar con doble antiagregación: según se explicó, antes de los 6 meses no se opera de forma electiva. Si no preguntas el porqué, no te enteras.

> **Hemoglobina glicosilada**
> Análisis que refleja la glucosa media de los **últimos 3 meses**. Es el verdadero indicador del control de la diabetes y determina el riesgo de infección y de mala cicatrización. No cambia en un día: por eso la glucemia de la consulta no la sustituye.

La glucemia capilar el día de la cirugía sirve para otra cosa: evitar una **bajada o subida brusca**. Se advirtió que la **hipoglucemia** es más peligrosa a corto plazo (puede provocar pérdida de conocimiento en minutos), mientras que valores algo altos en un diabético conocido (por ejemplo 160-200) suelen ser tolerables. Por eso se pregunta: «¿ha tenido hipoglucemias graves? ¿lleva jeringa de **glucagón**?», y se pide que venga comido.

Imagínalo así

Una glucemia alta es como un depósito casi vacío que te permite llegar un rato; una hipoglucemia es como un frenazo en autopista: el problema aparece de golpe y hay que saber qué hacer en el acto.

Así cae en el test

Pregunta típica del tema: ¿qué prueba mide el control de la diabetes? **Hemoglobina glicosilada**. Y: ¿qué riesgo agudo se anticipa en un diabético en el sillón? La **hipoglucemia**. En cualquier caso, justifica que preguntas por la causa de la medicación antes de decidir.

Idea clave

Anticoagulados: se pregunta el motivo, se consulta al médico y se hace hemostasia local. Antirresortivos: vía, dosis y duración. Diabetes: hemoglobina glicosilada para el control y glucagón para la emergencia.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

10 **Un paciente toma anticoagulantes o antiagregantes. ¿Qué hay que averiguar primero y qué se hace con la medicación?**

A Por qué los toma; no se modifican sin consultar al médico y se planifica hemostasia local.

B La dosis; se suspenden siempre una semana antes de operar.

C Su precio; se sustituyen por un antibiótico.

D Nada, porque no influyen en la cirugía de implantes.

Respuesta correcta: **A**

Lo primero es preguntar por qué los toma: puede ser una válvula cardíaca (que exige profilaxis) o un infarto reciente (que contraindica operar de forma electiva antes de 6 meses). Los anticoagulantes rara vez se suspenden y, si se plantea, se consulta al médico; se planifica hemostasia local.

A **Por qué los toma; no se modifican sin consultar al médico y se planifica hemostasia local.** ✓ Correcta
Correcta. El motivo puede cambiar la decisión por completo y rara vez se suspende.

B **La dosis; se suspenden siempre una semana antes de operar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En clase se dijo que rara vez se suspenden y nunca sin consultar.

C **Su precio; se sustituyen por un antibiótico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene sentido clínico ni se plantea.

D **Nada, porque no influyen en la cirugía de implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Influyen en el sangrado y exigen planificar la hemostasia.

11 **Mujer de 72 años que toma un antirresortivo por osteoporosis desde hace 4 años, sana por lo demás, pide dos implantes posteriores mandibulares. ¿Cuál es la actitud correcta?**

A Tratar con normalidad porque la osteoporosis no afecta a la cirugía.

B Rechazar el caso por estar contraindicado.

C Consultar vía, dosis y duración antes de decidir e informar del riesgo específico.

D Tratar con profilaxis antibiótica prolongada.

Respuesta correcta: **C**

Con antirresortivos hay que conocer vía, dosis y duración por el riesgo de osteonecrosis y seguir el protocolo; además se informa del riesgo específico. No es ni normal ni contraindicación automática.

A **Tratar con normalidad porque la osteoporosis no afecta a la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El antirresortivo conlleva un riesgo específico que debe valorarse.

B **Rechazar el caso por estar contraindicado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una contraindicación absoluta; se valora según el fármaco.

C **Consultar vía, dosis y duración antes de decidir e informar del riesgo específico.** ✓ Correcta
Correcta. Es la conducta que se pide para pacientes con antirresortivos.

D **Tratar con profilaxis antibiótica prolongada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la medida indicada y no sustituye a conocer la vía, la dosis y la duración.

Para revisar: La clase planteó esta pregunta como punto de control, pero el profesor no dio explícitamente la solución en la parte disponible; la respuesta se infiere de lo dicho sobre vía, dosis y duración.

12 **¿Qué dato refleja el control metabólico del paciente diabético y condiciona el riesgo de infección y de cicatrización?**

A La glucemia capilar medida el mismo día de la cirugía.

B El nombre del fármaco antidiabético que toma.

C Los años transcurridos desde el diagnóstico.

D La hemoglobina glicosilada.

Respuesta correcta: **D**

La hemoglobina glicosilada refleja la glucosa media de unos 3 meses y no cambia en un día, por lo que es el verdadero indicador del control y del riesgo de infección y cicatrización. La glucemia puntual sirve para otra cosa.

A **La glucemia capilar medida el mismo día de la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sirve para evitar bajadas o subidas bruscas, pero no mide el control.

B **El nombre del fármaco antidiabético que toma.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Lo que importa es el control metabólico, no el fármaco.

C **Los años transcurridos desde el diagnóstico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No refleja el control actual de la enfermedad.

D **La hemoglobina glicosilada.** ✓ Correcta
Correcta. Refleja el control de los últimos tres meses y determina el riesgo.

13 ¿Por qué conviene preguntar a un paciente diabético por episodios de hipoglucemia grave y si lleva glucagón?

A Porque con la glucemia alta no existe ningún riesgo.

B Porque una hipoglucemia puede hacerle perder el conocimiento en la consulta, y el glucagón es el tratamiento de emergencia.

C Porque el glucagón se usa para calcular la dosis de vasoconstrictor.

D Porque permite medir la hemoglobina glicosilada sin análisis.

Respuesta correcta: **B**

La clase destacó que una hipoglucemia puede producir pérdida de conocimiento en minutos en el sillón. Por eso se pregunta por episodios previos y por si lleva jeringa de glucagón, y se pide al paciente que venga comido.

A **Porque con la glucemia alta no existe ningún riesgo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Una hiperglucemia mantenida también es peligrosa; no es ese el motivo.

B **Porque una hipoglucemia puede hacerle perder el conocimiento en la consulta, y el glucagón es el tratamiento de emergencia.** ✓ Correcta
Correcta. Es una emergencia rápida y peligrosa que hay que poder atender.

C **Porque el glucagón se usa para calcular la dosis de vasoconstrictor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El glucagón no se usa para eso.

D **Porque permite medir la hemoglobina glicosilada sin análisis.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No sustituye a la prueba de laboratorio.

6 Exploración general, tensión, pruebas y riesgo ASA

3 preguntas del test

Con la anamnesis ya sabes si puedes operar y qué debes controlar. Ahora se mira al paciente **antes incluso de abrir la boca**: tamaño de maxilares, oclusión, cicatrices, apertura. Se emplean las cuatro técnicas semiológicas: **inspección, palpación, percusión y**

auscultación (esta última, en odontología, se deriva al médico, pero se toman constantes).

> **Tensión arterial**
> Es **obligatorio** tomarla antes de una cirugía. Los anestésicos con vasoconstrictor la elevan, y el dolor también. Si la tensión está alta, sangra más, se pierde la anestesia, duele, se pone más anestesia y la tensión sube más: es un **círculo vicioso**.

Cómo se actuó con la tensión según la clase

- Por encima de **200**: urgencia hipertensiva (riesgo de ictus o infarto). No se opera.
- Se intentó bajarla con medicación y, si **en 10-15 minutos no baja** hasta unos 160, se remite al médico y se reevalúa otro día.
- Con cifras en torno a 150-160 se puede operar sabiendo que sangrará más y controlando la hemostasia.
- Los pacientes nerviosos suben algo la tensión en el sillón; no exijas 120 mm Hg.

Pruebas complementarias: hemograma, coagulación, bioquímica, electrocardiograma, radiografía de tórax, biopsia… Se piden **para resolver una duda concreta**, y de forma rutinaria solo en cirugía hospitalaria con anestesia general. Antes de pedir una, pregúntate si su resultado va a cambiar tu diagnóstico o tu actitud terapéutica.

Imagínalo así
Pedir una prueba y no mirarla es como pedir un informe a un perito y archivarlo sin leer: legalmente sabías lo que contenía. La responsabilidad es de quien la pide. Por eso **nunca se pide una prueba sin verla**; si no vas a mirar un TAC de control, no lo pidas.

Clasificación ASA de riesgo quirúrgico

ASA	Paciente	Actitud en clase
1	Sano.	Se trata sin modificaciones.
2	Enfermedad sistémica leve.	Se trata con ciertas modificaciones y controles.
3	Enfermedad sistémica severa, normalmente no	No se trata de forma electiva hasta que esté controlado; sí las

ASA	Paciente	Actitud en clase
	controlada.	urgencias.
4	Enfermedad incapacitante con riesgo vital.	No se trata en la consulta.
5	Paciente moribundo.	No se trata.

Así cae en el test

Se evalúa **qué haces con cada nivel**, no memorizar la definición. Normalmente tratamos ASA 1 y 2; en ASA 3 se exige que esté controlado antes de operar. El ASA solo **pone nombre al riesgo**: la decisión sigue siendo tuya y la justificas con la anamnesis.

Idea clave

Tensión siempre antes de operar (200 = urgencia). Pruebas solo si responden una duda y se revisan. ASA 1-2 se tratan, ASA 3 solo si está controlado.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

14 **Antes de una cirugía, un paciente presenta 200 mmHg de tensión pese a haber tomado su medicación. ¿Qué procede?**

A Se considera urgencia hipertensiva: no se opera; se intenta bajarla y, si no desciende en 10-15 minutos, se remite a su médico.

B Operar con más anestesia con vasoconstrictor para controlar el dolor.

C Operar sin vasoconstrictor y sin más precauciones.

D Operar, porque ya se tomó la pastilla.

Respuesta correcta: **A**

A partir de 200 se considera urgencia hipertensiva, con riesgo de ictus o infarto. Además el vasoconstrictor y el dolor suben más la tensión y el sangrado, creando un círculo vicioso. Si no baja a unos 160 en 10-15 minutos, se remite.

A **Se considera urgencia hipertensiva: no se opera; se intenta bajarla y, si no desciende en 10-15 minutos, se remite a su médico.** ✓ Correcta
Correcta. La clase fijó 200 como urgencia hipertensiva y la actitud de no operar.

B **Operar con más anestesia con vasoconstrictor para controlar el dolor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El vasoconstrictor y el dolor suben la tensión, empeorando el círculo vicioso.

C **Operar sin vasoconstrictor y sin más precauciones.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Aumenta el sangrado y la pérdida de anestesia, y sigue habiendo riesgo vital.

D **Operar, porque ya se tomó la pastilla.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Lo importante es la cifra, no haber tomado la medicación.

Para revisar: Los umbrales (200 urgencia; operar hasta 150-160) son el criterio práctico del profesor, no una norma citada.

15 ¿Cuándo está justificado pedir una prueba complementaria?

A De forma sistemática a todos los pacientes.

B Solo para tener respaldo legal aunque nadie la mire.

C Siempre que el paciente lo pida.

D Cuando resuelve una duda concreta, su resultado puede cambiar el diagnóstico o la actitud terapéutica, y se va a revisar.

Respuesta correcta: **D**

Las pruebas se piden para responder a una duda concreta; antes de pedirlas hay que preguntarse si su resultado cambiará el diagnóstico o la actitud. Y nunca se pide una prueba sin verla, porque la responsabilidad legal es de quien la pide.

A **De forma sistemática a todos los pacientes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La rutina se reserva a cirugía hospitalaria con anestesia general.

B **Solo para tener respaldo legal aunque nadie la mire.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Pedirla y no verla genera responsabilidad.

C **Siempre que el paciente lo pida.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La decisión depende de la duda clínica y de si cambiará la conducta.

D **Cuando resuelve una duda concreta, su resultado puede cambiar el diagnóstico o la actitud terapéutica, y se va a revisar.** ✓ Correcta
Correcta. Es el criterio que se dio, junto con no pedir nunca una prueba sin verla.

16 **Un paciente ASA 3 necesita un implante de forma electiva. ¿Qué conducta se indicó en clase?**

A Tratarlo sin cambios, como a un ASA 1.

B Tratarlo con pequeñas modificaciones, como a un ASA 2.

C No tratarlo de forma electiva hasta que su enfermedad esté controlada, salvo urgencias.

D Contraindicar para siempre todo tratamiento dental.

Respuesta correcta: **C**

ASA 1 y 2 se tratan (con modificaciones en el 2). El ASA 3 tiene enfermedad sistémica severa y normalmente no controlada: no se trata de forma electiva hasta que esté controlado, salvo que sea algo vital.

A **Tratarlo sin cambios, como a un ASA 1.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un ASA 1 es un paciente sano; el ASA 3 tiene enfermedad severa.

B **Tratarlo con pequeñas modificaciones, como a un ASA 2.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa conducta corresponde al ASA 2, con enfermedad leve.

C **No tratarlo de forma electiva hasta que su enfermedad esté controlada, salvo urgencias.** ✓ Correcta
Correcta. El ASA 3 no se trata hasta estar controlado.

D **Contraindicar para siempre todo tratamiento dental.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se difiere hasta el control, no se contraindica de por vida.

Para revisar: El pasaje de la clase sobre los niveles ASA es confuso; la conducta por nivel se infiere de lo que se repite en clase (ASA 1 nada, ASA 2 modificar, ASA 3 esperar control).

7 Cuándo derivar y cómo hacer una buena interconsulta

1 pregunta del test

Se deriva cuando el **riesgo médico supera lo que puedes controlar en tu gabinete**, no cuando el caso te incomoda. Es decir, cuando necesitas ayuda médica externa.

Una interconsulta útil le dice al médico **qué vas a hacer**, porque él no necesita saber de implantes, sino entender el procedimiento médico:

1. Qué procedimiento (por ejemplo, cirugía de dos implantes).
2. Cuánto va a durar.
3. Qué anestesia usarás y con qué concentración de vasoconstrictor.
4. Qué medicación implica.
5. Qué **preguntas concretas** le haces (por ejemplo, si procede modificar la anticoagulación).

Ejemplo

Preguntar «¿puede operarse mi paciente de un implante?» deja al médico sin datos. Si en cambio le dices «cirugía de 45 minutos, anestesia local con vasoconstrictor, ¿procede ajustar la anticoagulación?», puede responder con una pauta concreta.

La **respuesta del médico se archiva en la historia**. Si él decide algo distinto de lo que tú necesitas (por ejemplo, retirar la anticoagulación más días de los necesarios), tú anotas qué necesitabas, qué recomendó y qué decidió él: la decisión médica es suya.

Así cae en el test

En un caso práctico, justifica la derivación con el riesgo médico, no con comodidad, y redacta la interconsulta indicando procedimiento, duración, anestesia, medicación y pregunta concreta.

Idea clave

Deriva por riesgo médico que no controlas. Interconsulta = procedimiento + duración + anestesia + medicación + pregunta concreta, y la respuesta se archiva.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

17 ¿Cómo se redacta una interconsulta útil al médico del paciente?

A Preguntando solo si el paciente «puede operarse».

B Indicando procedimiento, duración, anestesia y medicación implicada, y formulando preguntas concretas.

C Pidiendo al médico que elija la técnica y el número de implantes.

D Evitando dar datos del procedimiento para no confundirlo.

Respuesta correcta: **B**

Se deriva cuando el riesgo médico supera lo controlable en el gabinete. La interconsulta útil explica qué procedimiento, cuánto dura, qué anestesia y medicación implica, y hace preguntas concretas; la respuesta se archiva.

A **Preguntando solo si el paciente «puede operarse».** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una pregunta demasiado vaga para que responda con una pauta.

B **Indicando procedimiento, duración, anestesia y medicación implicada, y formulando preguntas concretas.** ✓ Correcta
Correcta. El médico no conoce los implantes: necesita saber qué se hará para responder.

C **Pidiendo al médico que elija la técnica y el número de implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La decisión odontológica no corresponde al médico.

D **Evitando dar datos del procedimiento para no confundirlo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sin esos datos no puede ajustar la medicación.

8 Exploración oral, dientes vecinos y registros iniciales

4 preguntas del test

El orden importa: **primero el paciente, luego la radiografía**. Se tratan pacientes, no radiografías. Si alguien llega con su escáner, se explora antes de mirarlo.

Orden de las maniobras

1. **Inspección**: mucosa, lengua, suelo de boca y dientes, incluidas las caras posteriores.
2. **Palpación**: consistencia, dolor, movilidad, adenopatías y secreciones.
3. **Percusión**: dolor periapical y periodontal.
4. Después, radiografía, TAC y pruebas complementarias.

Qué se valora

- **Tejidos blandos y fenotipo (biotipo)**: fino o grueso. En el sector anterior es casi tan importante como la técnica quirúrgica.
- **Dientes vecinos**: infecciones activas, número y forma de las raíces. Un implante recto puede chocar con el ápice curvo del diente contiguo.
- **Apertura oral, ATM y bruxismo**: se detectan en la primera visita y **modifican el presupuesto**.
- Oclusión, periodoncia, parafunciones y estética (labio, tercio facial).

Ejemplo

Si un implante invade el ápice del diente de al lado, el paciente tendrá dolor y el diente puede necrosarse. Es un error que a cualquiera le puede ocurrir. Lo malo es **negar el problema**; lo correcto es reconocerlo y **corregirlo** (cambiar o recolocar el implante) y vigilar el diente.

Ejemplo

En un paciente con fuerte bruxismo (todos los dientes inferiores desgastados), la carga inmediata aumenta el riesgo de fracaso. El profesional debe **informar de que la carga inmediata tiene más riesgo** y, si no la hace, lo registra. No es ético minimizar ese riesgo para cobrar más.

> **Registros iniciales**
> Fotografías, vídeos y escáner intraoral del estado inicial, y a veces encerado diagnóstico, mock-up o modelos montados en articulador semiajustable. Son registros **que no se pueden repetir** y la mejor prueba de cómo llegó el paciente, útil si luego se queja del resultado.

El flujo digital (escáner, mock-up virtual, planificación en ordenador) no ha sustituido estos pasos, solo los ha digitalizado. Con un mock-up el paciente puede ver y aceptar o rechazar el resultado antes de tocarlo.

Así cae en el test

Se espera que sepas ordenar la exploración (paciente antes que imagen) y detectar hallazgos que cambian el plan: biotipo, dientes vecinos, apertura, ATM y bruxismo.

Idea clave

Paciente antes que radiografía. Biotipo, dientes vecinos, apertura, ATM y bruxismo se miran en la primera visita. Las fotos del inicio no se pueden repetir.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

18 ¿Qué orden se sigue entre la exploración del paciente y la imagen?

A Primero se explora al paciente (inspección, palpación, percusión) y después se usa la radiografía.

B Se empieza por la radiografía y luego se explora al paciente.

C Se parte del escáner que trae el paciente y se omite la exploración.

D Se realiza solo la radiografía si el paciente refiere no tener síntomas.

Respuesta correcta: **A**

Se insistió en que el diagnóstico comienza con la exploración clínica en un orden: inspección, palpación y percusión, y solo después se utilizan la radiografía y el escáner para planificar. Tratamos pacientes, no radiografías.

A **Primero se explora al paciente (inspección, palpación, percusión) y después se usa la radiografía.** ✓ Correcta
Correcta. Se tratan pacientes, no radiografías.

B **Se empieza por la radiografía y luego se explora al paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se invierte el orden.

C **Se parte del escáner que trae el paciente y se omite la exploración.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La exploración clínica no puede omitirse.

D **Se realiza solo la radiografía si el paciente refiere no tener síntomas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La exploración es necesaria igualmente.

19 **Tras colocar un implante, el paciente refiere dolor en el diente contiguo y la radiografía muestra el implante contactando con su ápice. ¿Qué actitud es correcta?**

A Atribuir el dolor al diente y mantener el implante.

B Esperar a ver si el dolor desaparece solo.

C Reconocerlo y corregirlo (recolocar o cambiar el implante), vigilando el diente.

D Tratar solo el diente sin modificar el implante, para evitar otra cirugía.

Respuesta correcta: **C**

Dañar un diente vecino puede pasar. Lo reprobable es insistir en que el implante está bien. Hay que reconocerlo, corregir la posición y vigilar el diente, que suele recuperarse.

A **Atribuir el dolor al diente y mantener el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se niega la causa y el diente puede acabar necrosándose.

B **Esperar a ver si el dolor desaparece solo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Si el implante sigue comprimiendo el ápice, el problema persiste.

C **Reconocerlo y corregirlo (recolocar o cambiar el implante), vigilando el diente.** ✓ Correcta
Correcta. El error es negar el problema; corregirlo permite que el diente se recupere.

D **Tratar solo el diente sin modificar el implante, para evitar otra cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se deja la causa sin resolver.

20 ¿Qué hallazgos de la primera visita modifican el presupuesto según la clase?

A El estado civil, la profesión y las aficiones.

B El grupo sanguíneo, la talla y el peso.

C El tipo de seguro, la forma de pago y el horario.

D La apertura oral, la ATM y el bruxismo.

Respuesta correcta: **D**

La apertura oral, la ATM y el bruxismo se detectan en la primera visita y modifican el presupuesto (y, por ejemplo, el riesgo de la carga inmediata). Por eso hay que explorarlos siempre.

A **El estado civil, la profesión y las aficiones.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No determinan el presupuesto.

B **El grupo sanguíneo, la talla y el peso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No son los hallazgos señalados.

C **El tipo de seguro, la forma de pago y el horario.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son datos administrativos, no hallazgos clínicos.

D **La apertura oral, la ATM y el bruxismo.** ✓ Correcta
Correcta. Los tres se detectan en la primera visita y cambian el presupuesto.

21 ¿Por qué son especialmente valiosas las fotografías, vídeos o el escáner intraoral del estado inicial?

A Porque sustituyen al consentimiento informado.

B Porque son registros que no se pueden repetir y prueban cómo llegó el paciente.

C Porque evitan hacer cualquier radiografía o TAC.

D Porque solo sirven para publicidad de la clínica.

Respuesta correcta: **B**

Una vez tratado el paciente no se puede recuperar su situación inicial. Las fotos, vídeos y escáneres iniciales son registros irrepetibles y la mejor prueba para comparar si luego se queja del resultado.

A **Porque sustituyen al consentimiento informado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son documentos distintos con funciones distintas.

B **Porque son registros que no se pueden repetir y prueban cómo llegó el paciente.** ✓ Correcta
Correcta. Son la mejor prueba documental del estado de partida.

C **Porque evitan hacer cualquier radiografía o TAC.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las pruebas de imagen siguen siendo necesarias.

D **Porque solo sirven para publicidad de la clínica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tienen valor clínico y legal.

9 Planificar desde la prótesis hacia el implante

3 preguntas del test

Imagínalo así

Quieres comprar un coche y tienes una plaza de garaje. No empiezas por el coche que te gusta: primero miras **cuánto mide la plaza**. Si es de moto, ni sueñes con un monovolumen. En implantología, la «plaza» es el espacio protésico y la pérdida de tejidos del paciente.

La planificación sigue un orden que **no** empieza por el hueso:

1. Decidir **qué prótesis necesita** el paciente según los tejidos perdidos (solo la corona, corona y encía, o todo el proceso alveolar).
2. Calcular **cuántos implantes** hacen falta para sostener esa prótesis.
3. Comprobar si hay **hueso suficiente** (estudio radiológico, cantidad y calidad ósea) o si hacen falta regeneración u otras técnicas (cigomáticos, pterigoideos…).
4. Si el hueso no basta, rediseñar el plan o regenerar.

Ejemplo

Un paciente que solo ha perdido la corona no necesita una sobredentadura (no cabría y levantaría el labio); uno que ha perdido todo el proceso alveolar no se resuelve con una sola corona de porcelana. **Lo que se necesita manda sobre lo que se pide.**

Con ayuda de programas de planificación y de inteligencia artificial se muestran al paciente seno, nervio y cresta, para que **entienda** sus riesgos. Ver una imagen convence más que mil palabras.

> **Preservación de la cresta**
> Técnica realizada en el momento de la extracción para minimizar la reabsorción. Tras extraer un diente el hueso se pierde: la mayor pérdida ocurre en los **tres primeros meses** y continúa hasta el año. La prótesis removible acelera esa pérdida y los implantes la frenan. La preservación **no lo evita del todo, lo reduce**. Es más fácil mantener que recuperar después.

Decisiones que no se improvisan

- Diseño de la **incisión** (convencional o mínimamente invasiva).
- **Una o dos fases** quirúrgicas.
- **Implante inmediato** o diferido.
- **Carga inmediata** o no, con la prótesis diseñada antes de tocar al paciente.

Todo eso se diagnostica, se planifica y se explica **antes de la cirugía**. Si durante la cirugía hace falta cambiar algo (por ejemplo, más implantes de los previstos), se informa al paciente. La idea central es vender **soluciones protésicas**, no implantes sueltos.

Así cae en el test

Caso típico: desdentado parcial posterior mandibular con borde bajo y estrecho, fenotipo fino, poca encía queratinizada y no fumador. Debes justificar prótesis fija o removible, una o dos fases e injerto de tejido blando. Puntúa el **razonamiento** (desde la prótesis, valorando hueso y tejidos blandos), no una clasificación memorizada.

Idea clave

La prótesis manda: prótesis → número de implantes → hueso/técnicas. Preservar en la extracción porque es la única oportunidad de conservar. Las decisiones quirúrgicas se planifican antes.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

22 Según la secuencia de planificación explicada, ¿por dónde se empieza?

A Por la prótesis que necesita el paciente, luego los implantes necesarios y después se comprueba si hay hueso.

B Por el hueso disponible, y luego se decide qué prótesis cabe.

C Por el implante comercial que se desee usar.

D Por el presupuesto que el paciente quiere gastar.

Respuesta correcta: **A**

La planificación se hace desde la prótesis hacia el implante: primero qué prótesis necesita el paciente, luego cuántos implantes hacen falta, y después se valora si el hueso basta o si hacen falta técnicas avanzadas. Empezar por el hueso puede dejarte sin espacio.

A **Por la prótesis que necesita el paciente, luego los implantes necesarios y después se comprueba si hay hueso.** ✓ Correcta
Correcta. La prótesis manda.

B **Por el hueso disponible, y luego se decide qué prótesis cabe.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el orden contrario al defendido.

C **Por el implante comercial que se desee usar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La marca no condiciona la prótesis necesaria.

D **Por el presupuesto que el paciente quiere gastar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se informa, pero no es el punto de partida del diseño.

23 ¿Qué ocurre con el hueso tras una extracción y qué se hace si no se coloca implante en ese momento?

A El hueso se mantiene igual si se usa prótesis removible.

B No hay reabsorción si se espera a colocar el implante.

C La mayor pérdida ocurre en los tres primeros meses y continúa hasta el año; se hace preservación de la cresta para minimizarla.

D La preservación evita por completo cualquier pérdida de hueso.

Respuesta correcta: **C**

Tras extraer un diente se pierde el estímulo y el hueso se reabsorbe, sobre todo en los tres primeros meses y hasta un año. La removible acelera la pérdida y los implantes la frenan. Si no se coloca implante, se preserva la cresta para minimizar esa pérdida.

A **El hueso se mantiene igual si se usa prótesis removible.** ×
Incorrecta
Incorrecta. La prótesis removible acelera la pérdida.

B **No hay reabsorción si se espera a colocar el implante.** × Incorrecta
Incorrecta. La pérdida ocurre igualmente tras la extracción.

C **La mayor pérdida ocurre en los tres primeros meses y continúa hasta el año; se hace preservación de la cresta para minimizarla.**
✓ Correcta
Correcta. La preservación reduce la pérdida, no la elimina.

D **La preservación evita por completo cualquier pérdida de hueso.** ×
Incorrecta
Incorrecta. Solo la minimiza.

Para revisar: La cifra del 35% citada en clase no quedó clara en la clase, por eso no se usa como dato.

24 ¿Cuál de estas decisiones debe planificarse y explicarse antes de la cirugía en lugar de improvisarse?

A Decidir la carga inmediata sobre la marcha si el hueso parece bueno.

B Elegir una o dos fases en el momento de suturar.

C Cambiar el plan protésico acordado sin informar al paciente.

D Si se hará carga inmediata y con qué prótesis, decidido antes de tocar al paciente.

Respuesta correcta: **D**

Incisión, una o dos fases, implante inmediato y carga inmediata se diagnostican, planifican y explican al paciente antes de operar. Si hay carga inmediata, la prótesis se diseña antes de tocarle.

A **Decidir la carga inmediata sobre la marcha si el hueso parece bueno.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se improvisa en cirugía salvo que esté planificada.

B **Elegir una o dos fases en el momento de suturar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una decisión previa.

C **Cambiar el plan protésico acordado sin informar al paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cualquier cambio relevante se informa.

D **Si se hará carga inmediata y con qué prótesis, decidido antes de tocar al paciente.** ✓ Correcta
Correcta. La carga inmediata, la incisión y las fases se planifican de antemano.

10 El consentimiento informado como proceso

2 preguntas del test

El consentimiento informado **no es un papel**: es un **proceso de información** que termina en un documento. Todo lo que explicas al paciente en las visitas queda recogido en él como prueba de que ese proceso existió. Debe constar **por escrito** en cirugía y procedimientos invasivos.

Requisitos de validez

- Se entrega **con tiempo** para leerlo y preguntar. Un documento firmado el mismo día, sentado en el sillón, puede impugnarse: se recomienda que lleve **fecha anterior al día de la cirugía** (por ejemplo, enviándolo por correo varios días antes).
- El paciente puede **revocarlo en cualquier momento**, sin dar explicaciones.
- Debe estar **personalizado**: no vale un modelo genérico firmado y punto.

Contenido mínimo

Elemento	Detalle
Identificación	Del paciente (nombre con su letra) y del profesional.
Procedimiento	Descripción con lenguaje comprensible.
Alternativas	Razonables, **incluida la de no tratarse**.
Riesgos	Típicos del procedimiento y **personalizados** (por ejemplo, sangrado en un anticoagulado).
Consecuencias	De realizar el tratamiento y de **no** realizarlo.
Preguntas	Espacio para las dudas del paciente.
Fecha y firmas	La fecha no puede ser la del día de la cirugía.

Ejemplo

En un paciente de edad avanzada se escribe en la historia que acudió **acompañado** y que la familia conoce y firma el consentimiento. Así, si algo sale mal, se demuestra que no se le engañó.

Así cae en el test

Se pregunta qué hace válido el consentimiento: antelación, personalización, alternativas incluida no tratar, riesgos propios del paciente y revocabilidad. Recuerda que el criterio de la fecha anterior es la práctica que defendió el profesor.

Idea clave

Consentimiento = proceso, no papel. Con antelación, personalizado, con alternativas (incluida no tratar), con riesgos propios y revocable.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

25 ¿Por qué un consentimiento firmado el mismo día de la cirugía puede no considerarse válido?

A Porque debe firmarlo un notario.

B Porque el paciente puede alegar que no tuvo tiempo de leerlo ni pensarlo; debe entregarse con antelación y llevar fecha anterior.

C Porque solo es válido si se firma tras la cirugía.

D Porque solo puede firmarse en un hospital.

Respuesta correcta: **B**

El consentimiento es un proceso y el documento debe entregarse con tiempo para leerlo y preguntar. Firmado en el sillón el mismo día puede impugnarse por falta de tiempo; por eso se envía días antes y lleva una fecha anterior a la cirugía.

A **Porque debe firmarlo un notario.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se requiere notario.

B **Porque el paciente puede alegar que no tuvo tiempo de leerlo ni pensarlo; debe entregarse con antelación y llevar fecha anterior.**
✓ Correcta
Correcta. Es el criterio de validez defendido en clase.

C **Porque solo es válido si se firma tras la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Debe firmarse antes del procedimiento.

D **Porque solo puede firmarse en un hospital.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Puede firmarse en cualquier centro sanitario.

Para revisar: Se trata del criterio práctico defendido por el profesor; no se ha contrastado con la norma.

26 ¿Qué característica debe cumplir un consentimiento informado bien elaborado?

A Estar personalizado: con alternativas razonables incluida no tratarse, riesgos personalizados y la posibilidad de revocarlo.

B Ser un modelo genérico firmado y archivado.

C Estar redactado en lenguaje técnico para dar más rigor.

D Ser irrevocable una vez firmado.

Respuesta correcta: **A**

El documento recoge identificación, descripción comprensible del procedimiento, alternativas (incluida no tratar), riesgos típicos y personalizados, consecuencias de tratar y de no tratar, espacio para preguntas, fecha y firmas. Puede revocarse en cualquier momento.

A **Estar personalizado: con alternativas razonables incluida no tratarse, riesgos personalizados y la posibilidad de revocarlo.** ✓
Correcta
Correcta. Esos son los requisitos explicados en clase.

B **Ser un modelo genérico firmado y archivado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Debe personalizarse para el paciente.

C **Estar redactado en lenguaje técnico para dar más rigor.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Debe usar lenguaje comprensible.

D **Ser irrevocable una vez firmado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El paciente puede revocarlo en cualquier momento.

11 Medicación perioperatoria y profilaxis antibiótica en cirugía

2 preguntas del test

Antes de operar hay que dejar pautada la medicación para el **confort del paciente**: analgesia, antiinflamatorios y control de la ansiedad. Una pauta habitual comentada: antibiótico (si se decide), dos analgésicos **alternados** para que cuando uno pierde efecto el otro actúe, protector gástrico y un corticoide cuya dosis se ajusta al peso y a la evolución.

Precauciones

- Los **corticoides** pueden subir algo la glucemia y la tensión unos días. Avisa a diabéticos e hipertensos para que no corrijan su tratamiento por su cuenta.
- Los **AINE** son una de las primeras causas de ingreso hospitalario por **insuficiencia renal**. El cuadro aparece 5-6 días después y el paciente no lo asocia. En hipertensos conviene pautar otra analgesia (por ejemplo, paracetamol).

> **Profilaxis antibiótica en cirugía**
> Es la toma de antibiótico antes de la intervención para prevenir infección. **No está demostrada** su eficacia en cirugía de implantes y **no es obligatoria**, pero muchos profesionales la pautan. El antibiótico también tiene riesgos. La actitud propuesta es **consensuarla con el paciente** («¿desea tomar antibiótico para disminuir el riesgo de infección?») y aconsejarla en cirugías grandes con injertos.

Ejemplo

A un paciente a quien se le dio clindamicina por alergia a la penicilina le apareció una infección por Clostridium difficile y estuvo ingresado. Como lo había hablado con el profesional y lo entendía, no hubo reclamación. Si no se hubiese informado, habría sido un problema.

Así cae en el test

No hay que memorizar pautas, pero sí defender una decisión: la evidencia no obliga a dar profilaxis en cirugía de implantes, y lo que se decida se **informa y se anota**.

Idea clave

Profilaxis en cirugía: no demostrada, no obligatoria, consensuada con el paciente y registrada. AINE: riesgo renal, especialmente en hipertensos.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

27 ¿Qué riesgo debe tener presente el odontólogo al prescribir AINE, especialmente a un paciente hipertenso?

A Una hipoglucemia grave por interacción con la insulina.

B Una prolongación excesiva de la anestesia local.

C La insuficiencia renal, que puede aparecer varios días después de la prescripción.

D Ninguno, si se pautan solo unos días.

Respuesta correcta: **C**

Los AINE producen vasoconstricción de la arteria renal y son una causa importante de ingreso por insuficiencia renal, que se manifiesta días después. En hipertensos conviene valorar otra analgesia, como paracetamol.

A **Una hipoglucemia grave por interacción con la insulina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el riesgo señalado.

B **Una prolongación excesiva de la anestesia local.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se relaciona con los AINE.

C **La insuficiencia renal, que puede aparecer varios días después de la prescripción.** ✓ Correcta
Correcta. Los AINE son una causa frecuente de ingreso por insuficiencia renal.

D **Ninguno, si se pautan solo unos días.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El cuadro renal aparece precisamente a los 5-6 días de la toma.

28 ¿Qué se afirmó en clase sobre la profilaxis antibiótica en cirugía de implantes?

A Es obligatoria en todos los pacientes.

B Está contraindicada en cualquier caso.

C Solo se pauta cuando hay riesgo de endocarditis.

D No está demostrada su eficacia ni es obligatoria; conviene consensuarla con el paciente, sobre todo en cirugías grandes.

Respuesta correcta: **D**

La profilaxis de la infección quirúrgica en implantes no está demostrada ni es obligatoria, pero muchos la pautan. Dado que el antibiótico también tiene riesgos, se consensúa con el paciente y se aconseja en cirugías grandes con injertos.

A **Es obligatoria en todos los pacientes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las guías no la consideran obligatoria.

B **Está contraindicada en cualquier caso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se puede pautar si el paciente quiere o la cirugía es grande.

C **Solo se pauta cuando hay riesgo de endocarditis.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La profilaxis de endocarditis es otra cosa.

D **No está demostrada su eficacia ni es obligatoria; conviene consensuarla con el paciente, sobre todo en cirugías grandes.** ✓ Correcta
Correcta. Se recomienda ofrecerla y registrar la decisión.

12 Profilaxis de endocarditis y emergencias en el gabinete

2 preguntas del test

No hay que confundir la profilaxis de la **infección quirúrgica** con la de la **endocarditis**. Aunque tampoco está claro que sirva, en la endocarditis se considera obligada en ciertos pacientes.

Se indica en riesgo alto

- Prótesis valvular o material protésico.
- Reparación valvular.

- Endocarditis previa.
- Cardiopatías congénitas.
- Trasplante cardíaco con valvulopatía.

Desde 2007 dejaron de ser indicación otras situaciones como el prolapso mitral o la miocardiopatía hipertrófica (la clase citó también otra situación cardíaca más).

Cómo se pauta

1. **Dosis única**, de 30 a 60 minutos antes del procedimiento.
2. La pauta habitual de la clase fue amoxicilina 2 g por vía oral.
3. Si hay **alergia a penicilina**, cefalexina 2 g u otra cefalosporina (salvo antecedente de alergia grave).
4. Alternativas citadas: azitromicina o claritromicina 500 mg, o doxiciclina 100 mg.
5. **No se recomienda clindamicina** desde 2021 por reacciones adversas más frecuentes y graves, especialmente Clostridium difficile.
6. Anota en la historia que el paciente refiere haberla tomado (fármaco, dosis, hora); no se le obliga a tomarla delante de ti, pero sí debes preguntar y registrar.

Las **emergencias** más frecuentes en el gabinete son síncope vasovagal, crisis hipertensiva, hipoglucemia y reacción alérgica. Las cuatro se **anticipan desde la historia** (ansiedad, tensión arterial, diabetes, alergias). Es obligatorio tener el maletín con la medicación mínima al día y un protocolo conocido por todo el equipo.

> **Así cae en el test**
>
> Es probable que se pregunte la **indicación** (qué pacientes) y la **pauta** (dosis única previa, sin clindamicina). Recuerda lo explicado sobre qué dejó de ser indicación.

> **Idea clave**
>
> Profilaxis de endocarditis solo en riesgo alto, dosis única 30-60 min antes y sin clindamicina. Las emergencias se previenen desde la anamnesis.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

29 ¿En qué paciente se indica profilaxis antibiótica de endocarditis antes del procedimiento?

A Con prolapso de válvula mitral.

B Portador de prótesis valvular cardíaca, con dosis única 30-60 minutos antes.

C Con miocardiopatía hipertrófica.

D Con hipertensión arterial bien controlada.

Respuesta correcta: **B**

La profilaxis de endocarditis se limita a riesgo alto: prótesis valvular o material protésico, reparación valvular, endocarditis previa, cardiopatías congénitas y trasplante cardíaco con valvulopatía. Se da en dosis única 30-60 minutos antes y se anota.

A **Con prolapso de válvula mitral.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Desde 2007 dejó de ser indicación.

B **Portador de prótesis valvular cardíaca, con dosis única 30-60 minutos antes.** ✓ Correcta
Correcta. Es una indicación de riesgo alto.

C **Con miocardiopatía hipertrófica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tampoco es indicación actual.

D **Con hipertensión arterial bien controlada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una indicación de profilaxis de endocarditis.

Para revisar: El listado de situaciones que dejaron de ser indicación no quedó claro en la clase; solo se toman prolapso mitral y miocardiopatía hipertrófica.

30 ¿Qué se dijo en clase sobre la clindamicina como alternativa en pacientes alérgicos a la penicilina?

A Ya no se recomienda por reacciones adversas más graves, sobre todo infección por Clostridium difficile.

B Es el antibiótico de elección.

C Se prefiere porque basta una dosis única.

D Solo está contraindicada en niños.

Respuesta correcta: **A**

Para alérgicos a penicilina se citaron cefalexina u otra cefalosporina, azitromicina, claritromicina o doxiciclina. La clindamicina ya no se recomienda (desde 2021 según la clase) por reacciones adversas más frecuentes y graves, especialmente Clostridium difficile.

A **Ya no se recomienda por reacciones adversas más graves, sobre todo infección por Clostridium difficile.** ✓ Correcta
Correcta. Es la razón por la que se desaconseja.

B **Es el antibiótico de elección.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se desaconsejó.

C **Se prefiere porque basta una dosis única.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La dosis no es el criterio; hay otras alternativas.

D **Solo está contraindicada en niños.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La recomendación es general.

Para revisar: La clase dio el año 2021 y las alternativas, pero ese fragmento de la clase no quedó del todo claro.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ La historia clínica debe permitir contestar tres preguntas: ¿puedo operar?, ¿qué tiene? y ¿qué le voy a hacer?

- ✓ Es un documento asistencial y legal, regulado por la Ley 41/2002, confidencial, con conservación mínima de 5 años; al paciente se da copia de los datos clínicos, nunca el original.

- ✓ Lo que no está escrito no se hizo: se registra todo, incluidas las alternativas ofrecidas y la decisión del paciente.
- ✓ La primera visita empieza con una pregunta abierta y debe identificar las expectativas; si son irreales, se rechaza el caso antes de empezar.
- ✓ La anamnesis se hace por sistemas, se cuantifica el tabaco y se pregunta qué ocurrió realmente en las alergias.
- ✓ La medicación se contrasta y se averigua el porqué: anticoagulados (hemostasia local, consulta al médico), antirresortivos (vía, dosis y duración) y diabetes (hemoglobina glicosilada y riesgo de hipoglucemia).
- ✓ La tensión se toma siempre antes de operar; a partir de 200 es urgencia hipertensiva. El ASA 3 no se trata de forma electiva hasta que esté controlado.
- ✓ Las pruebas se piden para resolver una duda concreta y siempre se revisan. Se deriva por riesgo médico, con una interconsulta concreta.
- ✓ Primero se explora al paciente y después se mira la imagen. Biotipo, dientes vecinos, apertura, ATM y bruxismo cambian el plan y el presupuesto.
- ✓ El plan se construye desde la prótesis hacia el implante; en la extracción conviene preservar la cresta.
- ✓ El consentimiento es un proceso: con antelación, personalizado, con alternativas incluida no tratar, y revocable.
- ✓ La profilaxis antibiótica en cirugía no es obligatoria y se consensúa con el paciente; la de endocarditis se limita a riesgo

alto, en dosis única y sin clindamicina.

Glosario

Anamnesis
Parte de la historia clínica obtenida mediante la entrevista con el paciente.

Lex artis
Práctica profesional considerada correcta en cada momento; marca lo que debe hacerse por escrito o de una manera determinada.

Ley 41/2002
Ley de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones sobre información y documentación clínica.

Consentimiento informado
Proceso de información al paciente que se plasma en un documento personalizado, firmado con antelación y revocable.

ASA
Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología del riesgo quirúrgico, de ASA 1 (sano) a ASA 5.

Hemoglobina glicosilada
Análisis que refleja el control medio de la glucemia en los últimos 3 meses.

Glucagón
Fármaco inyectable de emergencia para tratar una hipoglucemia grave.

Antirresortivo
Fármaco para la osteoporosis que frena la pérdida de hueso; exige conocer vía, dosis y duración antes de operar.

Urgencia hipertensiva
Tensión muy elevada (en clase, a partir de unos 200) con riesgo de ictus o infarto.

Interconsulta
Consulta a otro profesional sanitario con datos concretos del procedimiento y preguntas concretas.

Fenotipo (biotipo) gingival
Grosor de la encía, fino o grueso, que condiciona el resultado estético.

Preservación de la cresta
Técnica en la extracción para minimizar la reabsorción ósea posterior.

Carga inmediata
Colocación de la prótesis sobre los implantes en el mismo acto o en muy poco tiempo; conlleva más riesgo.

Profilaxis de endocarditis
Dosis única de antibiótico antes del procedimiento en pacientes de riesgo cardíaco alto.

> **Clostridium difficile**
> Bacteria que causa diarrea grave tras antibióticos, sobre todo con clindamicina.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.